



- CNTTS 抗炎排炎 重启生命健康机制 -

全球首创 CNTTS抗炎抗衰调理中心

华夏乘黄（北京）健康科技有限公司

| 人体炎症 急性炎症与慢性炎症的区别

急性炎症：

- 病菌入侵人体导致
- 一般采用抗生素治疗，俗称“消炎”

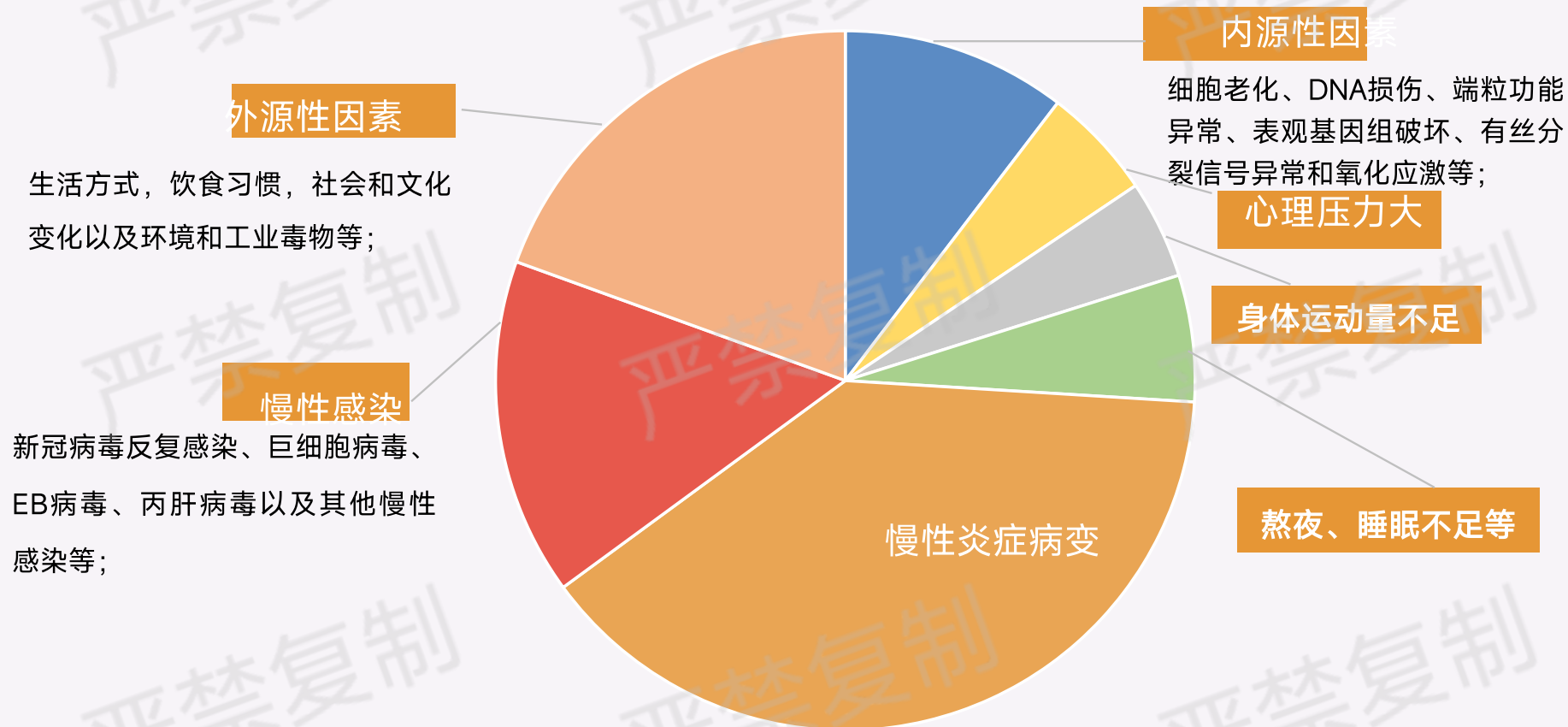
当细菌和病毒等病原体入侵人体时就会引发急性炎症，此时免疫系统开启，身体内一些濒临死亡的细胞也会放出炎症因子，这时候也会吸引巨噬细胞前来进行“吞噬”和“消化”而在这个过程中也会促进新的细胞生成，完成一次更新迭代。

慢性炎症：

- 体内炎症因子导致
- 使用抗生素治疗无效，无红、肿、热、痛表现

由于各种因素的影响，造成体内慢性的长期的“炎症因子”增加，免疫系统对炎症刺激长期反应，其特征是单核白细胞（单核细胞和淋巴细胞）的持续聚集，并伴随着持续炎症反应带来的组织损伤，这就是“慢性炎症”。

| 慢性炎症不可避免



| 慢性炎症的危害 破坏免疫系统 引发各种疾病

无炎症，不慢病

大部分慢性病，包括动脉硬化、糖尿病、高血压、高血脂、很多肿瘤、阿尔茨海默病、帕金森、关节炎、哮喘、痛风、多发性硬化症、抑郁症、免疫力低下、痤疮都与慢性炎症有关。

炎症引发衰老及各类疾病

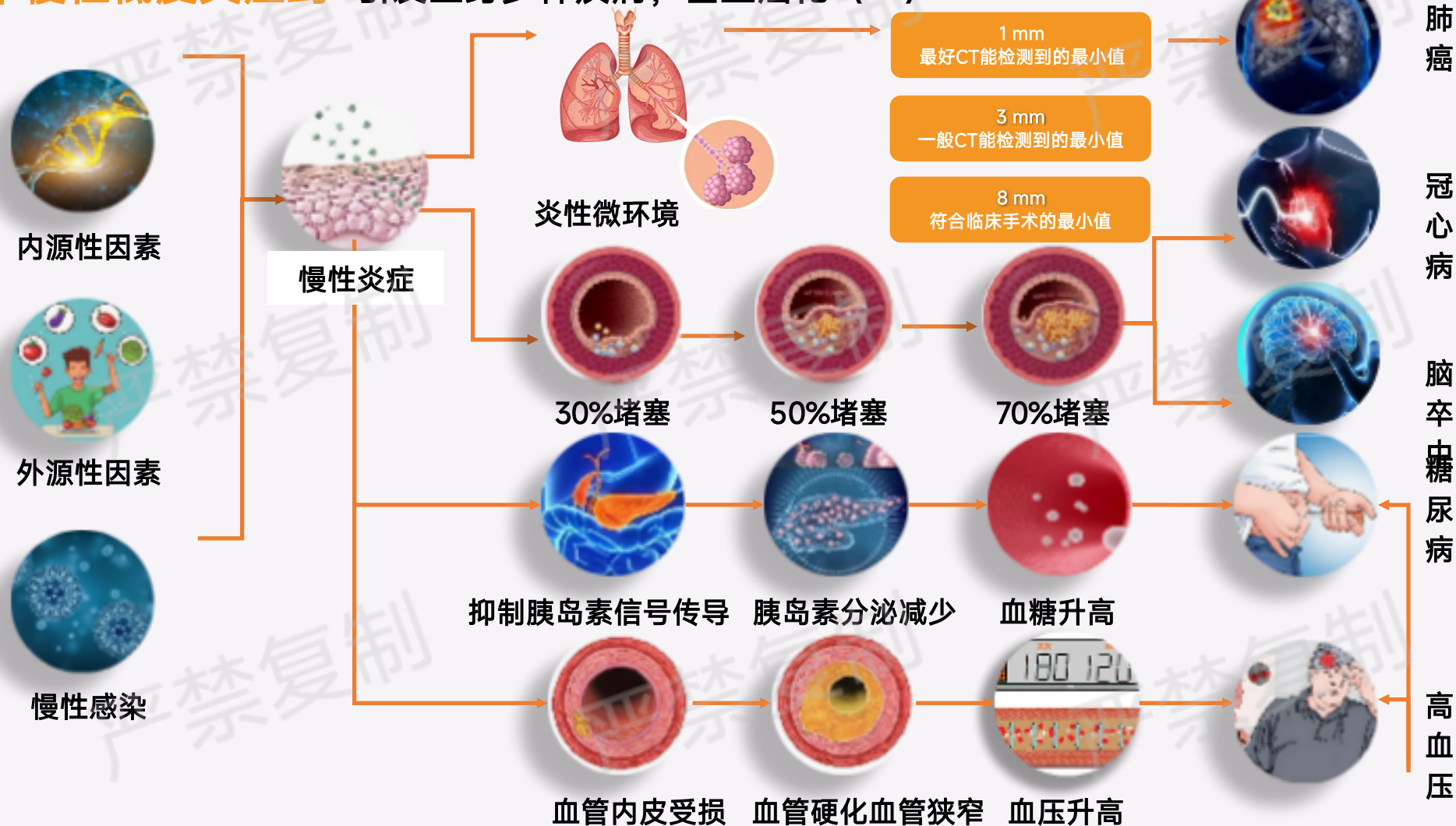
- 大意大利博洛尼亚大学教授Claudio Franceschi提出的“炎症衰老理论”认为：衰老是一种全身性慢性炎症的过程，并引发与年龄有关的各类疾病，如：癌症、动脉粥样硬化、心血管疾病、II型糖尿病和阿尔茨海默病等。

慢性炎症导致死亡比例居高不下

- 2022年，美国国立卫生研究院统计显示，全球范围内，每5人中有3人会死于慢性炎症相关疾病。慢性炎症，如鼻炎、咽炎等长久不消的症状，不但加重免疫系统负担，还会引发炎症衰老，导致恶性循环。



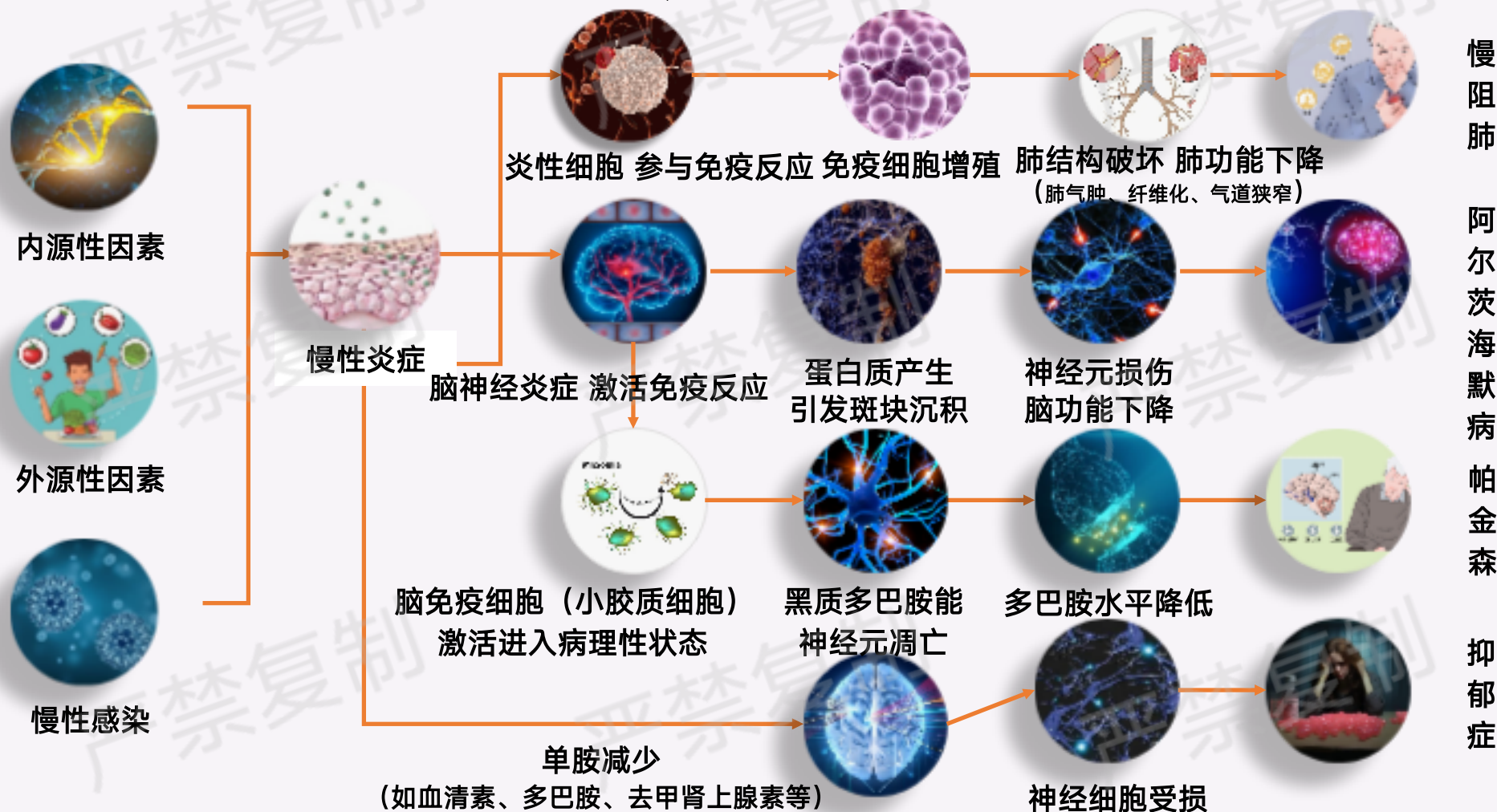
慢性低度炎症到 引发全身多种疾病，甚至癌化（一）



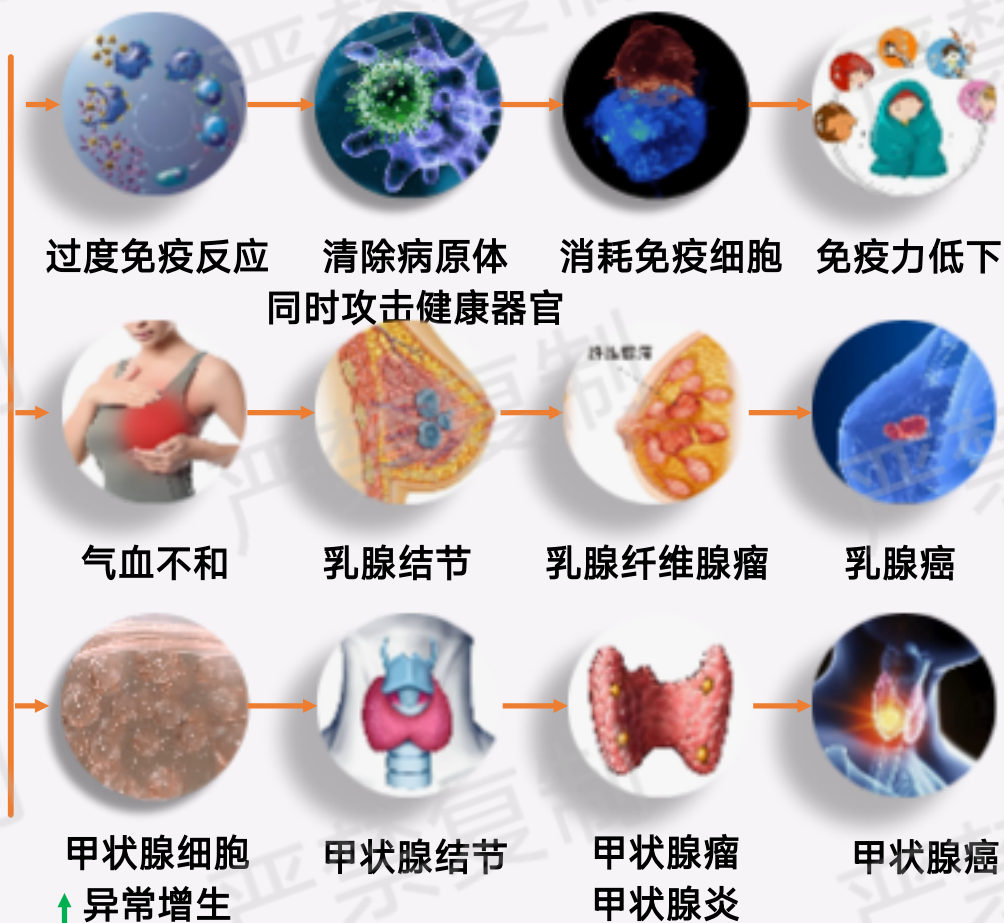
接上一页：慢性炎症引发的疾病



慢性低度炎症到 引发全身多种疾病，甚至癌化（二）



接上一页：慢性炎症引发的疾病



调理 (CNTTS抗炎范畴)



治疗

| 慢性炎症的危害 加速衰老

世界卫生组织权威发布：慢性炎症水平是人体衰老的重要指数-慢性炎症水平越高，衰老越快。

● 慢性炎症是人体衰老的重要标志

2023年，全球顶级期刊《Cell》刊发了来自全球顶级高校和科研院所的研究论文：《Hallmarks of aging: An expanding universe》，首次提出：慢性炎症是人体衰老的重要标志，对于理解人体衰老的发生、发展以及如何干预衰老过程意义巨大。

● 炎症积累可加速机体的炎症性衰老

2023年，《Nature》发表题为“Inflammation and Aging: Signaling Pathways and Intervention Therapies”的文章，指出：炎症与衰老相互作用形成恶性循环，机体内的炎症会损害HSC（造血干细胞）的自我更新能力并加速细胞衰老，心脏、脑、肝脏、肾脏等其他器官的衰老与炎症因子、细胞和器官功能等密切相关，炎症积累或加速了机体的炎症性老化。

● 正常范围内CRP值的高低与健康状态密切相关

流行病学研究发现，长寿大国日本，其人群的慢性炎症水平在世界上最低（比中国人群约低30%），这个结果提示体内慢性炎症水平也许是日本人健康程度优于中国的一个原因。

● 百岁老人的慢性炎症水平普遍偏低

身体健康的百岁以上的老人（包括预期寿命长达100年以上的人）的CRP水平大部分低于



降低炎症水平
有助于缓解机体衰老

| 如何了解自身慢性炎症水平 血常规检查CRP值

CRP（C反应蛋白）是由肝脏合成的急性时相反应蛋白，可反应全身整体上的非特异性炎症水平

CRP数值 (mg/L)	情况分析
0.5-2	成人正常范围
0-8	正常范围
10-50	轻度炎症
50-100	严重疾病
> 100	严重疾病并提示细菌感染

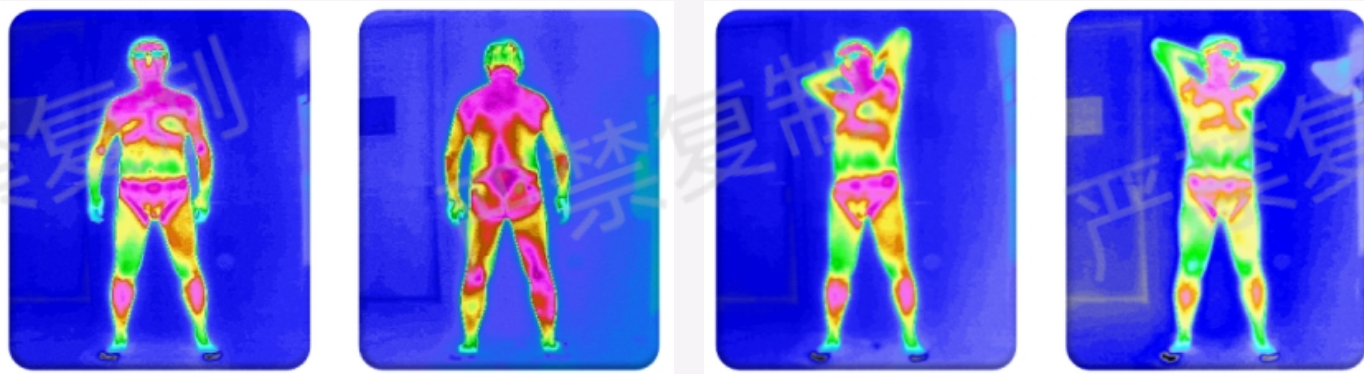
* CRP>2.1 VS CRP<1:

心肌梗塞的危险性 ↑ 2.9倍；缺血性中风的危险性 ↑ 1.9倍；

外周动脉血管性疾病的危险性 ↑ 4.1倍。

如何了解自身慢性炎症的主要部位 AI-TTM热层析扫描

AI-TTM技术依据热成像扫描技术 精准定位人体慢性炎症部位和脏器诊断组织炎症、组织损伤，退行性病变，血供异常，新陈代谢水平异常、神经调节功能异常。【检测报告图】作用原理是组织、脏器发生病理生理学变化，其对应部位热量分布发生变化；TTM被动接受人体热辐射，生成全身（或局部）热结构分布图像，并进行定量及定性分析。



- **安全绿色：**无辐射、无损伤，特异性高，结果准确度高；
- **全身筛查：**根据检查结果对全身进行综合评估，全面了解身体健康状况；
- **快速灵敏：**3分钟即可潜在疾病的发病趋势；
- **动态实时：**实时细胞代谢热变化，适合做预防效果的监测。

| 现有抗炎方法

健康饮食

多吃抗炎食物包括牛油果、草莓、
蓝莓、黑莓各种莓类；
不吃高热量食品、反式脂肪酸
减少烟酒摄入量

健康生活

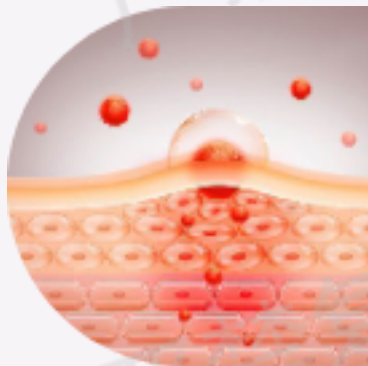
调节情绪，减轻压力
劳逸结合，保证高质量睡眠
合理运动，适度锻炼

注意卫生

避免在污染环境长期停留
保持居家环境的清洁

现有抗炎方法对降低慢性炎症的贡献度有限；对大多数人尤其是亚健康人群的抗炎效果有限；只能延缓慢性炎症累积速率。

高效抗炎的策略 定向消除“内炎症”



💡 药物修复

通过药物定向到达慢性炎症病变部位，即“内炎症”部位，修复受损细胞，降低炎症因子释放，是最有效的抗炎策略。



💡 TTS技术的诞生和发展

两千多年前，中医药就开始出现通过皮肤的用药技术：《山海经》中记载了中国最早的膏药。

二十世纪七十年代开始持续到今天，全球热研经皮用药技术：电离子导入、超声导入、电致孔技术、缓释贴技术、纳米微针技术等。

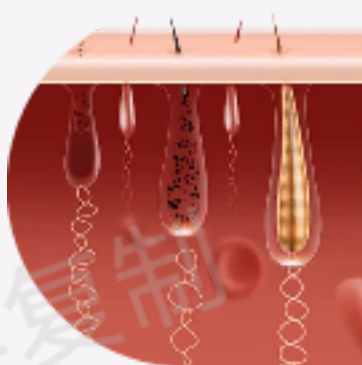
世界卫生组织将这种非创伤性通过皮肤用药的技术定义为全新用药名称：

Transdermal Therapeutic system
(TTS)



💡 慢性炎症部位血液循环不畅通

毛细血管被破坏或阻断，药物无法通过血液循环顺利输送到炎症病变的“内炎症”部位，很难形成有效浓度产生疗效。



💡 现有用药方式，药物在人体内的输送均需通过血液

用药方式：1.口服 2.注射 3.现有TTS

技术

药物进入血液循环后，无法顺利到达慢性炎症部位，定向抗炎效果很难显现。

| CNTTS变革现有血循给药，首创穴位经络用药

- ✔ CNTTS在全球的TTS研发热潮中另辟蹊径，颠覆创新，走出了全新的中国模式，书写了中医TTS研发的新历史。



颠覆性突破：CNTTS团队突破创新边界，以不懈的努力探索TTS未来

全球独创技术

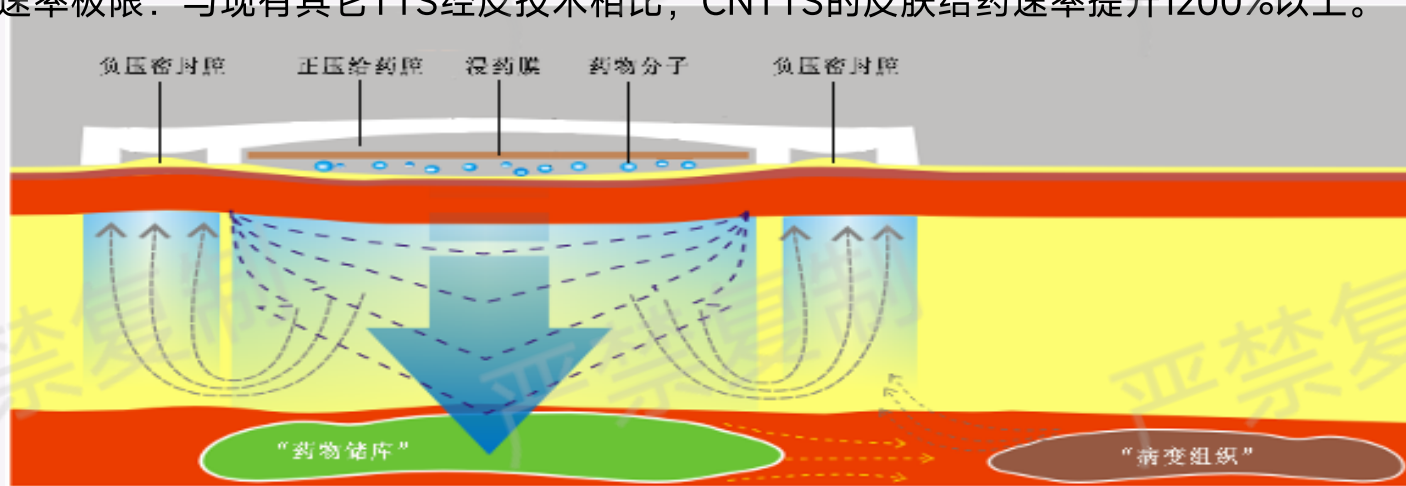
突破皮肤表面45摄氏度最高临界值的瓶颈：在距离皮肤表面不到1cm的空间内，最低温度55度，最高到达72度，持续1小时不烫伤皮肤。

全球领先水平

突破皮肤耐受压力极限：在皮肤表面形成高达-60KPa（5倍于普通拔罐的压力）持续1小时，不创伤皮肤。

全球领先技术

突破皮肤给药速率极限：与现有其它TTS经皮技术相比，CNTTS的皮肤给药速率提升1200%以上。



| 全方位创新: CNTTS团队凭借专业的技能和坚韧的毅力, 孕育出引领时代的精品



1.创新药材有效成分提取工艺:

节约中药材资源, 道地药材利用率大幅提升

2.创新用药剂型:

确保有效成分以纳米级大小经皮入穴

3.创新药物进入人体的路径:

穴位给药, 无创无痛

4.创新药物在人体内的输送路径:

经络传输, 靶向直达

5.创新中药用药治疗新理念:

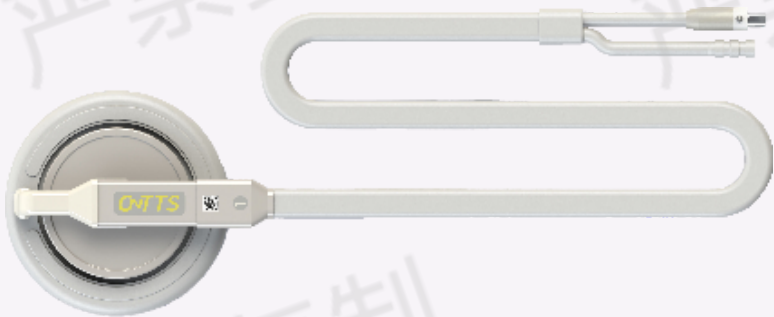
量化用药, 标准施治, 无需辩证, 普惠大众

| 创造中医器械研发的新历史（之一）

♥ 针对单项中医医疗器械产品技术研发持续时间：

5475天

131400小时



| 创造中医器械研发的新历史（之二） 单项中医器械研发资金投入：1.36亿元

CNTTS不断挑战自我，追求卓越。在长达十余年的研发历程中，团队以高度专业的态度，对数千个细节进行了反复优化。

仅针对CNTTS控释盘的单个部件的研发投入：

6年专项研发

9次产品迭代

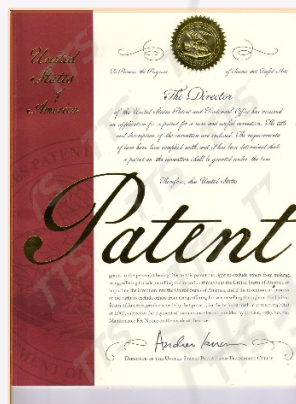
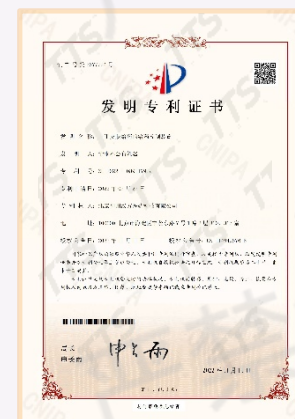
135款模具

1000+实验和分析

10000+性能和质量测试

10万+人次的临床测试

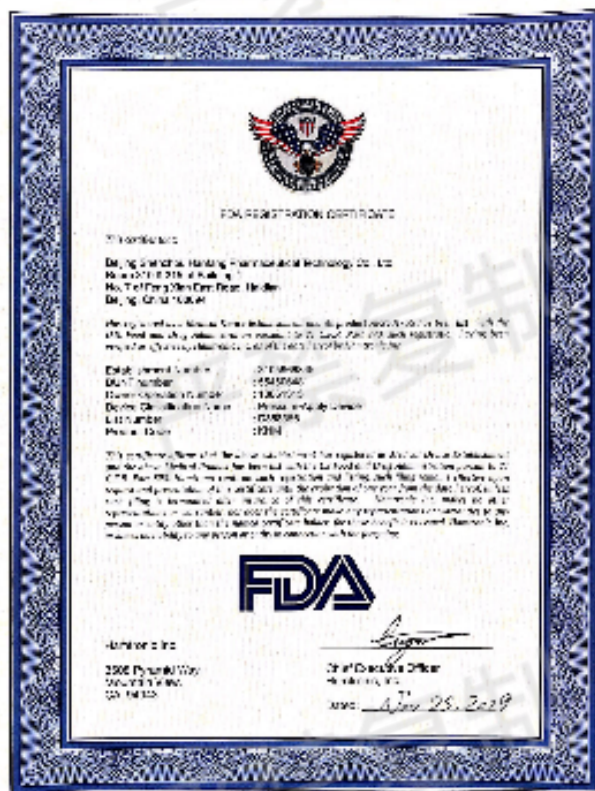
| 创造中医器械研发的新历史（之三） 单项中医器械获得31个国家授权的39项发明专利



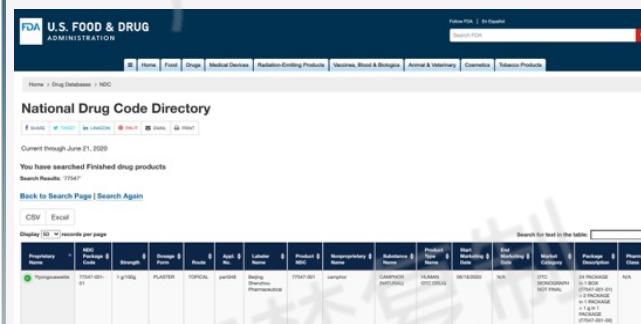
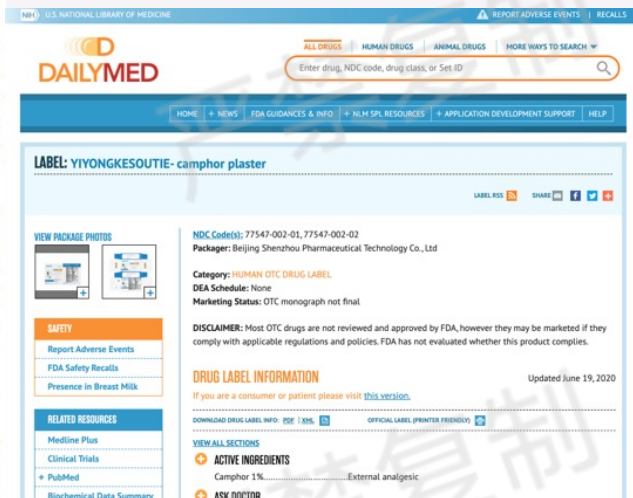
83天

2022年，国家专利局仅用83天快速批准两项发明专利授权，极大程度保护了“力热耦合”给药治疗这项全球突破性技术。

创造中医器械研发的新历史（之三）同时获得美国FDA医疗器械批件和NDC药物批件



Scanned with CamScanner



| CNTTS药物和设备技术研发以及临床科研测试协同和参与单位

各大医院及研究所

国家卫健委科学技术研究所	中国中医科学院药物研究所
中国中医科学院广安门医院	北京大学第三医院
北京大学人民医院	北京中日医院
北京协和医院	国药同煤三院TTS尘肺病治疗中心
解放军总医院	西安胸科医院呼吸与危重症科
清华大学	清华大学中西医结合医院
北京中医药大学附属东直门医院	富士康台北研发中心
中国医学科学院药用植物研究所	江西省肿瘤医院
武汉大学	陕西省心血管医院
北京市药检所	深圳宝安纯中医治疗医院

| CNTTS临床医学科研合作项目

国家自然科学基金（广安门医院呼吸科李光熙主任）：

基于抗原递呈活化肺巨噬细胞通路探讨温散酊治疗PAP（肺泡蛋白沉积症）作用机制，进行中，已有论文发表；

中国中医科学院广安门医院院内课题（呼吸科）：

透皮外用温散酊治疗痰浊阻肺型慢阻肺急性加重的临床观察，已结题并发表论文；

工信部、国家卫健委课题：

5G+中老年健康促进示范项目，进行中；

北京市科委课题(东直门医院心血管科)：

全国名中医郭维琴益气泻肺汤酊经皮治疗慢性心力衰竭的随机双盲安慰剂对照临床研究，进行中；

北京中医药大学附属东直门医院心血管科院内课题：

新汉方TTS中医载药治疗系统观察益气凉血生肌方改善PCI术后患者内皮功能的临床疗效评价研究，进行中；

科技创新 2030-

“癌症、心脑血管、呼吸和代谢性疾病防治研究”重大项目（广州医科大学第一附属医院牵头和天津中医药大学第二附属医院牵头两个课题组）申报中；

| CNTTS临床医学科研论文

序号	发表论文	发表单位
1	Chinese Medicine Rescues Acute Respiratory Dyspnea Syndrome Caused by COVID:A Case Report (中医药救治新冠引起的急性呼吸呼吸困难综合症)	《世界中西医结合杂志 (英文版) 》
2	《基于真实世界数据的温散酊透皮给药治疗肺结节的疗效评价》	《长春中医药大学学报》
3	《透皮外用温散酊治疗慢性咳嗽临床观察研究》	《世界中西医结合杂志》
4	《温散酊透皮外用治疗特发性肺泡蛋白沉积症5例临床观察》	《世界中西医结合杂志》
5	《镇痛松肌活血方经皮透入治疗椎管外慢性软组织损伤腰腿痛60例临床观察》	《国际中医中药杂志》
6	《透皮外用温散酊治疗痰浊阻肺型慢阻肺急性加重的临床观察》	中国中医科学院广安门医院
7	《中国中医科学院广安门医院呼吸科TTS临床使用评测告》	中国中医科学院广安门医院
8	《北京大学人民医院TTS妇科治疗效果报告》	北京大学人民医院

CNTTS部份媒体视频

CCTV13《朝闻天下》
新冠肺炎52s



CCTV《新闻联播》
全球疫情会诊室



山东卫视《大医本草堂》
慢阻肺（脾肺肾同治）1min



北京卫视《养生堂》
心脑血管



北京卫视《北京时间》
新冠肺炎42s



北京科教频道《健康北京》
哮喘



深圳市宝安纯中医治疗医院
肿瘤



安徽卫视
《健康大问诊》



CNTTS部份媒体视频

中国中医科学院广安门医院-肺泡蛋白沉积症



呼吸科



西安胸科医院-肺泡蛋白沉积症



心血管科



国药同煤三院-尘肺病



西安胸科医院-新冠后遗症

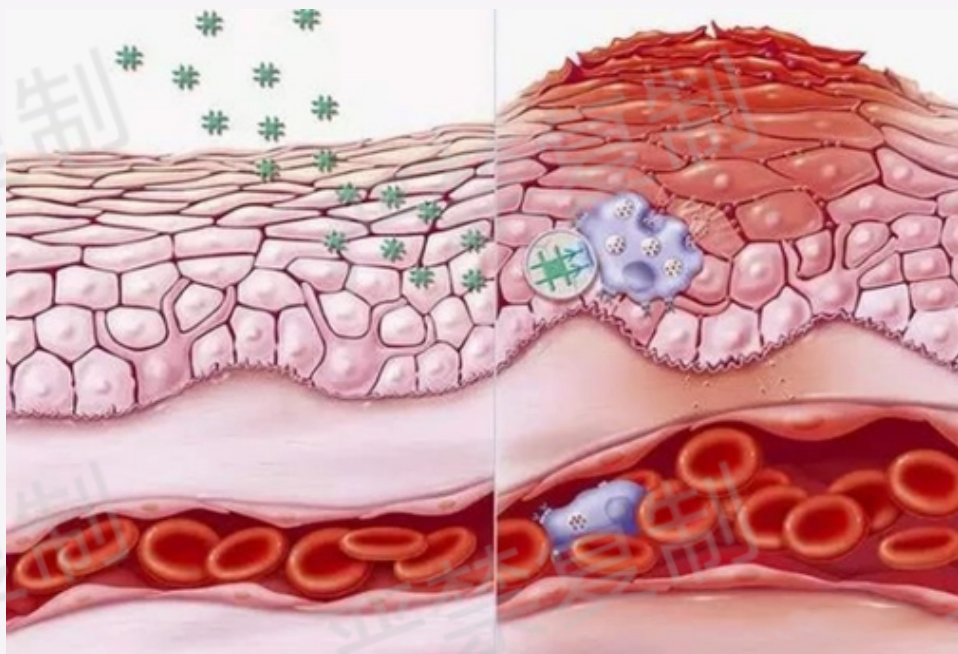


司马南



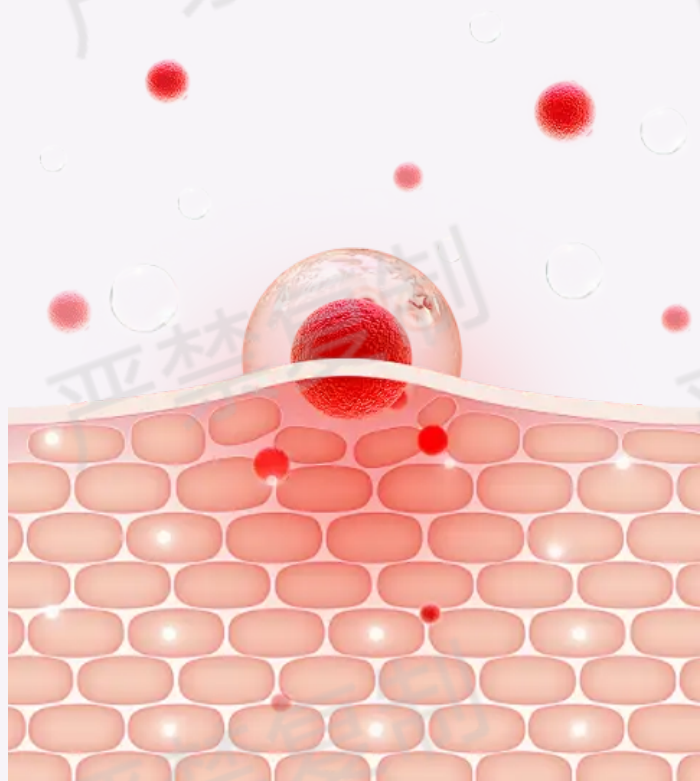
| CNTTS对“内炎症”疾病的高效治疗

从CNTTS在上述临床医疗领域里的表现可以看出，CNTTS对身体“内炎症”具有良好的减轻消除能力，针对炎症部位具有定向高效的抗炎作用。



*图示仅供参考

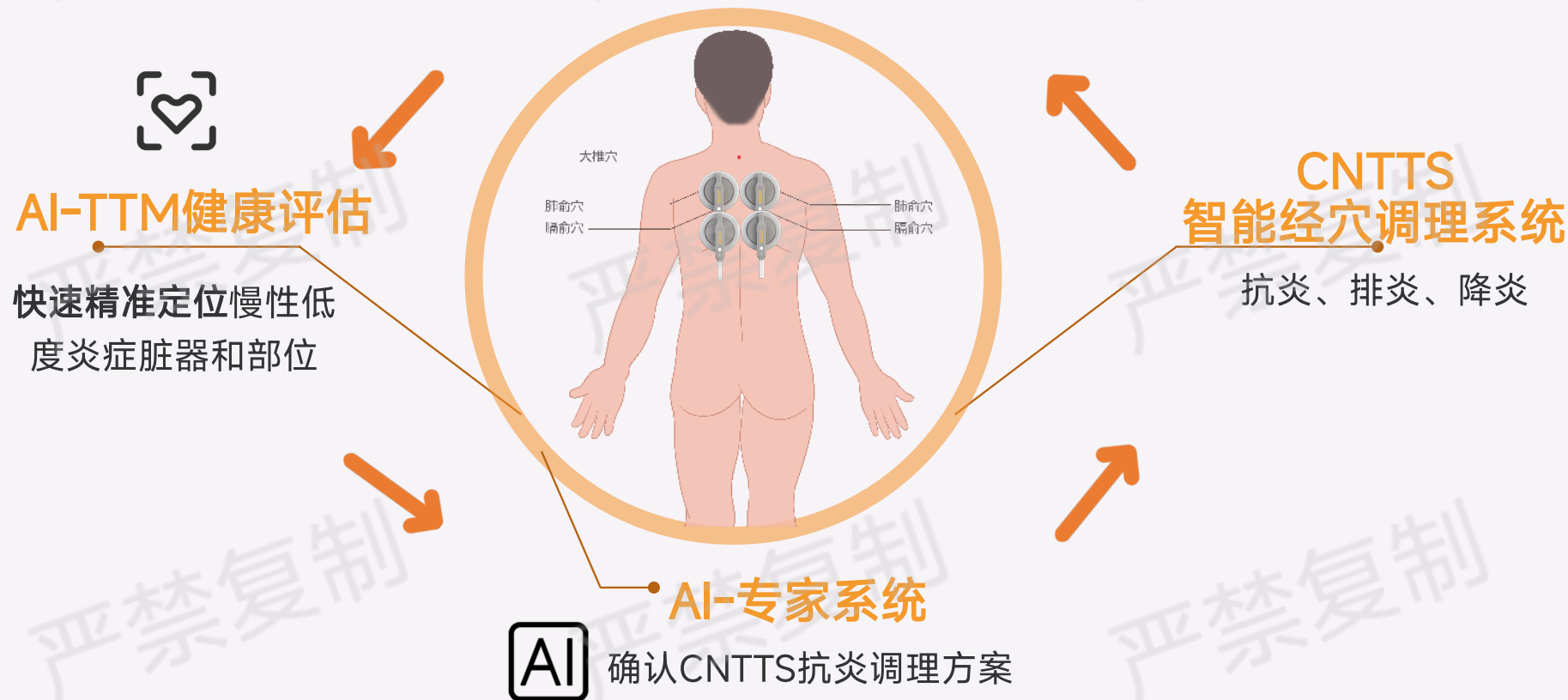
| CNTTS定向高效抗炎机理



- CNTTS系统采用独家的数智中医经络调理技术，安全地在穴位表皮形成最高温度可达70℃的“力热耦合压力井”，快速打开穴位皮肤通道，疏通深层经络，确保天然植物萃取液的有效成分定向到达效用部位。它为缺乏能量的病态细胞提供活化能，修复细胞损伤，促进抗炎因子释放，激发NK细胞和巨噬细胞生长，降低人体慢性炎症水平。
- CNTTS系统可作用于人体全身各个脏器需要修复的受损细胞和抗炎的部位，达到改善机体功能、提高机体免疫能力、降低疾病风险和抗衰老能力的作用，重启生命健康机制。

CNTTS抗炎调理路径

CNTTS抗炎降炎，效果可见



CNTTS抗炎调理典型客户案例

描述：客户汤某，无明确病症，
日常保健调理。

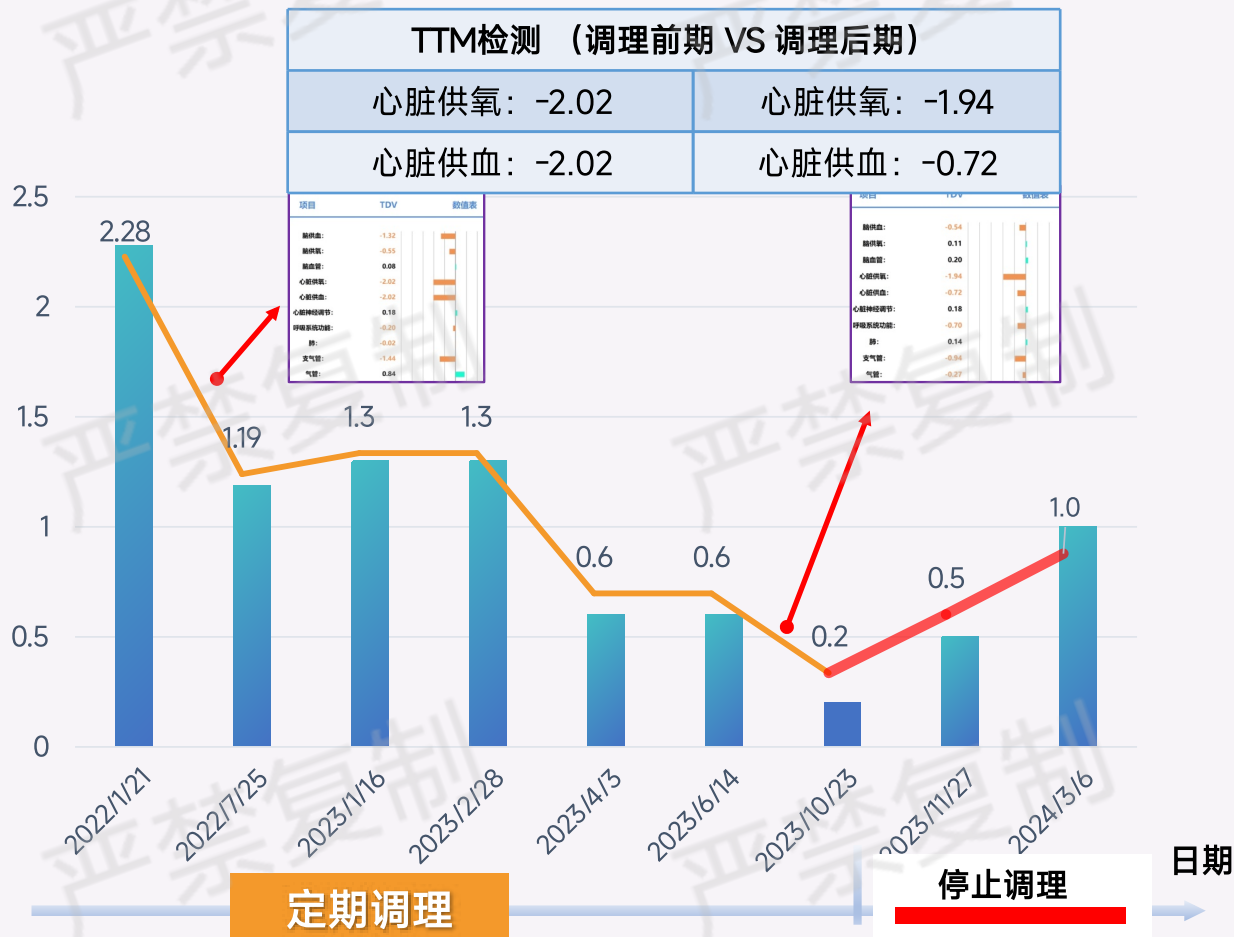
CNTTS调理方案

- 双肺俞穴+B，双膈俞穴+B
- 双肝俞穴+A，双肾俞穴+C
- 同时调理上述8个穴位，5次/周，
1次/天

CNTTS调理结果

- 经CNTTS调理，客户CRP数值逐步降低
- 停止调理后，CRP数值开始升高

研究报道百岁老人的CRP值（图表）



I CNTTS抗炎调理典型客户案例

卡号:0000183670 姓名:汤伟 报告时间: 2022/1/21				
项目名称	结果	单位	异常	参考范围
C-反应蛋白	2.28	mg/L		<10
★白细胞	5.08	*10 ⁹ /L		
★红细胞	5.17	*10 ¹² /L		
★血红蛋白	154	g/L		
★红细胞压积	47.4	%		
★平均红细胞体积	91.6	fL		

卡号:0000183670 姓名:汤伟 报告时间: 2022/7/25				
项目名称	结果	单位	异常	参考范围
★全血糖化血红蛋白测定	6.5	%	↑	4.0-6.2

C-反应蛋白	1.19	mg/L	
★白细胞	5.55	*10 ⁹ /L	
★红细胞	4.91	*10 ¹² /L	
★血红蛋白	150	g/L	
★红细胞压积	44.9	%	
★平均红细胞体积	91.5	fL	
★平均红细胞血红蛋白量	30.6	pg	
★平均红细胞血红蛋白浓度	335	g/L	
★红细胞分布宽度 (SD)	13.3	%	
★血小板计数	109	*10 ⁹ /L	
血小板平均体积	11	fL	
大血小板比率	31.7	%	
血小板分布宽度	16.5	%	
红细胞分布宽度 (SD)	45	fL	
血小板比积	0.101	%	
荧光免疫网织红细胞比率	92.9	%	

卡号:0000183670 姓名:汤伟 报告时间: 2023/1/16				
项目名称	结果	单位	异常	参考范围
★全血糖化血红蛋白测定	6.4	%	↑	4.0-6.2

C-反应蛋白	1.3	mg/L	
★白细胞	4.69	*10 ⁹ /L	
★红细胞	4.98	*10 ¹² /L	
★血红蛋白	150	g/L	
★红细胞压积	45.5	%	
★平均红细胞体积	91.3	fL	
★平均红细胞血红蛋白量	30.1	pg	
★平均红细胞血红蛋白浓度	330	g/L	
★红细胞分布宽度 (CV)	13.4	%	
★血小板计数	144	*10 ⁹ /L	
血小板平均体积	11.4	fL	
大血小板比率	35.3	%	
血小板分布宽度	16.5	%	
红细胞分布宽度 (SD)	44.7	fL	
血小板比积	0.106	%	
荧光免疫网织红细胞比率	89.3	%	

卡号:0000183670 姓名:汤伟 报告时间: 2023/2/28				
项目名称	结果	单位	异常	参考范围
★全血糖化血红蛋白测定	6.5	%	↑	

C-反应蛋白	1.3	mg/L	
★白细胞	6.47	*10 ⁹ /L	
★红细胞	5.09	*10 ¹² /L	
★血红蛋白	153	g/L	
★红细胞压积	46.6	%	
★平均红细胞体积	91.5	fL	
★平均红细胞血红蛋白量	328	g/L	
★平均红细胞血红蛋白浓度	334	%	
★血小板计数	208	*10 ⁹ /L	
血小板平均体积	10.3	fL	
大血小板比率	27	%	
血小板分布宽度	16.4	%	
红细胞分布宽度 (SD)	44.9	fL	
血小板比积	0.231	%	
荧光免疫网织红细胞比率	94.3	%	

卡号:0000183670 姓名:汤伟 报告时间: 2023/4/3				
项目名称	结果	单位	异常	参考范围
★全血糖化血红蛋白测定	6.2	%		

C-反应蛋白	0.6	mg/L	
★白细胞	4.37	*10 ⁹ /L	
★红细胞	4.99	*10 ¹² /L	
★血红蛋白	149	g/L	
★红细胞压积	45.8	%	
★平均红细胞体积	91.6	fL	
★平均红细胞血红蛋白量	29.9	pg	
★平均红细胞血红蛋白浓度	326	g/L	
★血小板计数	159	*10 ⁹ /L	
血小板平均体积	10.6	fL	
大血小板比率	30.7	%	
血小板分布宽度	16.4	%	
红细胞分布宽度 (SD)	45.6	fL	
血小板比积	0.171	%	
荧光免疫网织红细胞比率	90.6	%	

卡号:0000183670 姓名:汤伟 报告时间: 2023/6/14				
项目名称	结果	单位	异常	参考范围
C-反应蛋白	<0.20	mg/L		

C-反应蛋白	0.6	mg/L	
★白细胞	4.37	*10 ⁹ /L	
★红细胞	4.99	*10 ¹² /L	
★血红蛋白	149	g/L	
★红细胞压积	45.8	%	
★平均红细胞体积	92	fL	
★平均红细胞血红蛋白量	30.2	pg	
★平均红细胞血红蛋白浓度	330	g/L	
★血小板计数	158	*10 ⁹ /L	
血小板平均体积	10.7	fL	
大血小板比率	29.1	%	
血小板分布宽度	16.4	%	
红细胞分布宽度 (SD)	46.1	fL	
血小板比积	0.175	%	
荧光免疫网织红细胞比率	93.3	%	

卡号:0000183670 姓名:汤伟 报告时间: 2023/10/23				
项目名称	结果	单位	异常	参考范围
★全血糖化血红蛋白测定	6.3	%	↑	

C-反应蛋白	<0.20	mg/L	
★白细胞	5.6	*10 ⁹ /L	
★红细胞	5.25	*10 ¹² /L	
★血红蛋白	156	g/L	
★红细胞压积	48.3	%	
★平均红细胞体积	92	fL	
★平均红细胞血红蛋白量	29.7	pg	
★平均红细胞血红蛋白浓度	323	g/L	
★血小板计数	160	*10 ⁹ /L	
血小板平均体积	10.4	fL	
大血小板比率	29.1	%	
血小板分布宽度	16.4	%	
红细胞分布宽度 (SD)	46.1	fL	
血小板比积	0.175	%	
荧光免疫网织红细胞比率	93.3	%	

卡号:0000183670 姓名:汤伟 报告时间: 2023/11/27				
项目名称	结果	单位	异常	参考范围
★全血糖化血红蛋白测定	6.3	%	↑	

C-反应蛋白	0.6	mg/L	
★白细胞	5.55	*10 ⁹ /L	
★红细胞	4.9	*10 ¹² /L	
★血红蛋白	148	g/L	
★红细胞压积	44.8	%	
★平均红细胞体积	91.3	fL	
★平均红细胞血红蛋白量	30.2	pg	
★平均红细胞血红蛋白浓度	330	g/L	
★血小板计数	158	*10 ⁹ /L	
血小板平均体积	10.7	fL	
大血小板比率	30.4	%	
血小板分布宽度	16.5	%	
红细胞分布宽度 (CV)	14	%	
★血小板计数	158	*10 ⁹ /L	
血小板平均体积	10.7	fL	
大血小板比率	30.4	%	
血小板分布宽度	16.5	%	
红细胞分布宽度 (SD)	46.8	fL	
血小板比积	0.169	%	
荧光免疫网织红细胞比率	1.1	%	

卡号:0000183670 姓名:汤伟 报告时间: 2024/3/6				
项目名称	结果	单位	异常	参考范围
C-反应蛋白	0.8	mg/L		<10
★白细胞	5.74	*10 ⁹ /L		3.5-9.5
★红细胞	4.96	*10 ¹² /L		4.3-5.8
★血红蛋白	147	g/L		130-175
★红细胞压积	45.8	%		40-50
★平均红细胞体积	92.5	fL		82-100
★平均红细胞血红蛋白量	29.7	pg		27-34
★平均红细胞血红蛋白浓度	321	g/L		310-354
★红细胞分布宽度 (CV)	13.2	%		<15
★血小板计数	161	*10 ⁹ /L		125-350
血小板平均体积	10.4	fL		9.4-12.5
大血小板比率	27.8	%		Array
血小板分布宽度	16.6	%		9.0-17.0
★红细胞分布宽度 (SD)	43.9	fL		Array
血小板比积	0.168	%		0.106-0.282
荧光免疫网织红细胞比率	0.7	%		0.4-8
荧光免疫网织红细胞计数	0.04	10 ⁹ /L		0-1

卡号:0000183670 姓名:汤伟 报告时间: 2024/3/6				
项目名称	结果	单位	异常	参考范围
★全血糖化血红蛋白测定	6.3	%	↑	

C-反应蛋白	0.6	mg/L	
★白细胞	5.55	*10 ⁹ /L	
★红细胞	4.9	*10 ¹² /L	
★血红蛋白	148	g/L	
★红细胞压积	44.8	%	
★平均红细胞体积	91.3	fL	
★平均红细胞血红蛋白量	30.2	pg	
★平均红细胞血红蛋白浓度	330	g/L	
★血小板计数	158	*10 ⁹ /L	
血小板平均体积	10.7	fL	
大血小板比率	30.4	%	
血小板分布宽度	16.5	%	
红细胞分布宽度 (CV)	14	%	
★血小板计数	158	*10 ⁹ /L	
血小板平均体积	10.7	fL	
大血小板比率	30.4	%	
血小板分布宽度	16.5	%	
红细胞分布宽度 (SD)	46.8	fL	
血小板比积	0.169	%	
荧光免疫网织红细胞比率	1.1	%	

Array				
Array				

| CNTTS每天为超过2万+客户提供健康服务

CNTTS专业团队以不懈的努力探索产品未来，致力于研发独具匠心的健康产品，为用户带来前所未有的健康体验。

1

15家等级医院

2

19家三甲医院

3

229家基层医院

4

296家生美健康机构

5

415个 企事业“健康小屋”



重启生命健康机制

怕生病，来CNTTS